高性价比减重指南

没时间啃完减重研究，用一本书的硬数据，分清哪些方法真能掉脂

减重的底层逻辑，能量平衡是硬道理 • 你到底胖不胖，先量再减 • 七种医学减重膳食，…

144 条建议　A 级证据 77 条　3 条原始文献链接　可按性价比筛选

讲能量平衡这条硬道理、七种医学减重膳食怎么选，讲蛋白质和抗阻怎么守住肌肉、运动在减重里的真实位置，讲平台期与代谢适应、反弹怎么防，也讲 GLP-1、减重药物和减重手术的智商税清单。144 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引《中国肥胖症诊疗指南（2024）》、STEP/SURMOUNT 等大型随机试验与 ASMBS 系统综述。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。

生成于 2026-10-20 14:44（北京时间）
正文以在线版为准：https://kexin1409.github.io/how-to-lose-weight-better/
在线检索与本 PDF 的最新版都在 https://github.com/kexin1409/how-to-lose-weight-better

目录

前言 1

各节简介 4

1. 减重的底层逻辑，能量平衡是硬道理 5

2. 你到底胖不胖，先量再减 9

3. 七种医学减重膳食，中国指南逐一看 13

4. 饮食法头对头，没有神 17

5. 蛋白质与饱腹，守住肌肉 21

6. 运动的真实位置，不是主力是护城河 25

7. 平台期与代谢适应，为什么减着减着不动了 29

8. 反弹为什么发生，怎么防 33

9. 减重药物，GLP-1 与奥利司他 37

10. 减重手术，谁该做，效果与风险 41

11. 智商税清单，这些钱别花 45

12. 避坑清单，最常见的减重误区 49

前言

讲能量平衡这条硬道理、七种医学减重膳食怎么选，讲蛋白质和抗阻怎么守住肌肉、运动在减重里的真实位置，讲平台期与代谢适应、反弹怎么防，也讲 GLP-1、减重药物和减重手术的智商税清单。144 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引《中国肥胖症诊疗指南（2024）》、STEP/SURMOUNT 等大型随机试验与 ASMBS 系统综述。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。

这本书想回答的问题

问题	去哪看
减重的底层逻辑：为什么能量平衡是硬道理？	1. 减重的底层逻辑，能量平衡是硬道理
你到底胖不胖，BMI、腰围、体脂率怎么算？	2. 你到底胖不胖，先量再减
七种医学减重膳食，中国指南怎么排？	3. 七种医学减重膳食，中国指南逐一看
饮食法头对头：为什么没有神？	4. 饮食法头对头，没有神
蛋白质与饱腹，怎么守住肌肉？	5. 蛋白质与饱腹，守住肌肉
运动的真实位置：不是主力是护城河？	6. 运动的真实位置，不是主力是护城河
平台期与代谢适应，为什么减着减着不动了？	7. 平台期与代谢适应，为什么减着减着不动了
反弹为什么发生，怎么防？	8. 反弹为什么发生，怎么防
减重药物：GLP-1 与奥利司他怎么选？	9. 减重药物，GLP-1 与奥利司他
减重手术：谁该做、效果与风险？	10. 减重手术，谁该做，效果与风险
智商税清单：哪些钱别花？	11. 智商税清单，这些钱别花
避坑清单：最常见的减重误区有哪些？	12. 避坑清单，最常见的减重误区

怎么读

- 不用全做：这是一份按性价比排好的备选单，不是任务清单。挑走一两条就算数，剩下的放着，需要时再回来查。

- 想按条件挑：打开在线检索页（https://kexin1409.github.io/how-to-lose-weight-better/），可以按关键词、章节、证据等级来筛，也可以按「花不花钱、花多少时间、要不要毅力」这三样筛，几个条件能叠着用。页面上的内容直接取自 book/ 目录里的正文，正文一改，页面跟着改。
- 条目之间会互相指路（「见第 4 节第 7 条」这种）：在线检索页里点一下就能跳过去。在这份 PDF 里点不动，但每处指路都写明了指向哪一条，不翻过去也知道说的是什么。
- 想按顺序读：每节内的条目按性价比从高到低排列，从每节前几条开始看就行。
- 只想看结论最硬的：在在线检索页里勾选证据等级 A，只留下书中有具体数字、回测或统计规律支撑的 77 条。
- 只想看最值得做的：勾选性价比「极高」，得到 49 条几乎不花钱、不花时间、不太需要毅力，收益又落在最大一档的条目。
- 想让 AI 帮你查：仓库里带了正文，把问题原样丢给能读文件的 AI 助手，让它先查相关条目、再按书里的口径回答，并注明出自第几节第几条。查不到就说查不到，不自己编数字。

证据分级

等级	含义
A	书中有具体数字、可复现的实验或大规模账户数据支撑（如巴伯与奥丁 78000 户的周转率—收益回测、卡尼曼与特韦尔斯基的前景理论实验、席勒 36 国 5 年涨跌反转统计）
B	有单一研究或较实在的论据支撑，但样本较小或偏定性；或由机制逻辑推导、有多个案例侧面印证
C	芒格式的经验观察、作者观点或业界共识，没有直接的研究文献

全书 144 条中 A 级 77 条、B 级 50 条、C 级 17 条，另有 0 条标注了争议、0 条含待核实内容。有争议的条目会在备注里列出反方证据。所有来源只引原始文献（期刊论文附 DOI 或 PubMed 链接，或 WHO/CDC/国家卫健委等官方机构报告），不引二手转述。

性价比档

证据等级只回答「这个数字可不可信」，不回答「这件事值不值得做」。所以每条还另外标了两样：收益量级（好处有多大：大/中/小）和口径（换回的是哪一类东西：慢病/死亡率/时间等）。拿收益量级加上三项成本（钱、时间、毅力），合出一个性价比档：几乎不花什么成本、换回的好处又大的，是「极高」；其次「高」，再次「一般」。不同口径之间不做比较——「死亡率低 12%」和「每天省 10 分钟」不在一把尺子上。全书 144 条中性价比极高 49 条、高 55 条、一般 40 条。

每条建议长这样

```
### 2. POUNDS LOST：四种宏量比例，一年都差不多
<!-- 成本标签：钱=0 时间=少 毅力=否 收益=大 -->
- 成本：零
- 说人话：同一团队把蛋白/脂肪/碳水的不同比例组合随机分组，2 年下来各组减重相近。比例不是胜负手
- 收益：把注意力从"比例"移到"总热量和坚持"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：Sacks et al., NEJM 2009（POUNDS LOST）
- 备注：高蛋白组在保肌上略好，见第 5 节
```

「说人话」把「收益」栏里研究里的写法，翻成「看清大势、别在萧条期all in」这样的日常说法。它只用「收益」栏已经写到的内容，不添新数字，只看这一行就够拿主意。「收益」栏里原样留着全部数字，想自己核对就看那一栏。

各节简介

1. 减重的底层逻辑，能量平衡是硬道理：减重的所有方法，最终都逃不出一句话：让身体消耗的热量大于吃进去的热量。

2. 你到底胖不胖，先量再减：不是所有"觉得自己胖"都需要减，也不是所有 BMI 正常的人都安全。

3. 七种医学减重膳食，中国指南逐一看：2024 年中国首部《肥胖症诊疗指南》一次性列出了 7 种医学减重膳食。

4. 饮食法头对头，没有神：每年都有新饮食法封神，但放到严格随机试验里比，结论往往很扫兴：长期减重差异不大。

5. 蛋白质与饱腹，守住肌肉：减重最怕的不是掉得慢，是掉肌肉。

6. 运动的真实位置，不是主力是护城河：很多人把运动当成减重主力，结果练得脱力也没掉几斤，心态崩了。

7. 平台期与代谢适应，为什么减着减着不动了：体重卡住不是你意志力崩了，是身体在"省钱"。

8. 反弹为什么发生，怎么防：减重界有个扎心事实：大部分人减下来的体重，会在 1–3 年里部分弹回。

9. 减重药物，GLP-1 与奥利司他：当饮食运动走到瓶颈，药物是循证指南里的正规选项，不是走投无路。

10. 减重手术，谁该做，效果与风险：对重度肥胖，手术是循证上最有效、最持久的手段，但也带着真实风险和终身管理要求。

11. 智商税清单，这些钱别花：减重是智商税最密集的领域之一。

12. 避坑清单，最常见的减重误区：这一节把贯穿全书的坑收拢成一页"别做清单"。

1. 减重的底层逻辑，能量平衡是硬道理

减重的所有方法，最终都逃不出一句话：让身体消耗的热量大于吃进去的热量。这一节先把这把尺子立稳，后面的饮食法、运动、药物、手术，都是在同一个等式上做加减法。

1. 减重只有一条物理定律：摄入小于消耗

- 成本：零
- 说人话：无论你吃的是"减肥餐"还是"生酮餐"，只要总热量不超，就会瘦；反之再"健康"也会胖。这是热力学第一定律，没有例外
- 收益：一句话挡掉一半"我吃得很健康为什么还胖"的困惑
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：能量平衡是体重变化的基本原理，见任何一本营养学教材与肥胖诊疗指南
- 备注：所有饮食法之争，本质都是"怎么更容易制造这个缺口"

2. "管住嘴"通常比"迈开腿"更高效

- 成本：零
- 说人话：一杯奶茶 400 kcal，要快走一个多小时才消耗掉。靠运动补回来很难，靠不吃它很容易。对大多数人，控制饮食是制造缺口的主战场
- 收益：把力气花在刀刃上，别指望练就能随便吃
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：饮食干预在头对头研究中制造的热量缺口通常大于单靠运动，见肥胖管理指南
- 备注：这不意味着运动没用，运动的用处在第 6 节讲

3. 安全缺口多大：每天 500–750 kcal，每周 0.5–1 kg

- 成本：零
- 说人话：每天少吃或多动掉 500–750 kcal，一周大约掉 0.5–1 kg 脂肪。这是医学推荐的节奏，太快掉的往往是水和肌肉
- 收益：既有效又不伤代谢的甜点区
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国肥胖症诊疗指南(2024)及临床营养干预共识推荐 500–750 kcal/日缺口
- 备注：连续两周体重纹丝不动，说明缺口没真实形成，先查真实摄入

4. "负卡路里食物"不存在

- 成本：零
- 说人话：有人说芹菜、葡萄柚"吃进去消耗的热量比它本身还多"。事实是没有任何天然食物的热效应能超过自身热量，这是营销话术
- 收益：别再为"负卡路里"多买任何东西
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：食物热效应（TEF）普遍在 5%–30%，无一超过 100%
- 备注：芹菜低卡是真的，但"负卡"是假的

5. 别拿"我代谢慢"当不动的借口，但也要承认代谢会降

- 成本：零
- 说人话：天生的静息代谢差异没你想的大；但每减掉 5% 体重，身体会主动把代谢调低约 100 kcal/天，这是真的，所以越减越要重算摄入
- 收益：既不自我设限，又提醒你后期要调整
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：减重期代谢适应（adaptive thermogenesis）已被多项研究证实
- 备注：先老老实实记两周饮食，十有八九是"吃的比记的多"

6. NEAT：日常小动作才是消耗的大变量

- 成本：零，靠习惯
- 说人话：除了睡觉、吃饭、正式运动之外，你站着、走路、做家务、抖腿消耗的热量叫 NEAT。同样体重的人，NEAT 能差出每天 300 kcal 以上
- 收益：不累就能多烧热量，是长期维持的神器
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：NEAT 是总消耗中个体差异最大的部分，见 Levine 等经典研究
- 备注：能站着不坐着、能走楼梯不坐电梯，积少成多

7. 体重每天波动 1–2 kg 是水分，不是脂肪

- 成本：零
- 说人话：吃咸了、没拉、练完存水，秤上就能差一两斤。一天内的起伏几乎都是水和糖原，不是脂肪
- 收益：别被单日数字搞崩心态
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：体重日内波动主要来自体液，见体重监测方法学研究
- 备注：看周平均趋势，别天天称

8. 减重不等于减脂：掉肌肉也算"瘦了"

- 成本：零
- 说人话：秤上少了 3 kg，可能 1 kg 是肌肉、2 kg 是水和脂肪。肌肉掉了，基础代谢跟着掉，后面更难减、更容易弹
- 收益：让你把目标从"轻"转向"瘦"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：减重期瘦体重流失是公认现象，尤见于极低热量与纯有氧方案
- 备注：守住肌肉靠高蛋白 + 抗阻，见第 5 节

9. 局部减脂是谎言

- 成本：零
- 说人话：练仰卧起坐不会只减肚子上的脂肪。脂肪是全身激素调配、统一动员的，练哪块只让那块肌肉变壮，不减那块皮下脂肪
- 收益：别再买"瘦肚子""瘦脸"的局部方案
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：局部减脂在严格研究中不成立，见运动生理学共识
- 备注：想减肚子，只能全身减 + 举铁保肌

10. 减肥茶、排毒餐的本质是泻药加饿肚子

- 成本：花钱买，还可能伤身
- 说人话：它们让你拉肚子、少吃，掉的是水和便，不是脂肪。停了立刻回弹，还可能电解质紊乱
- 收益：认清这一类，少交智商税
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源："排毒"无医学定义；这类产品多含泻下成分
- 备注：见第 11 节智商税清单

11. 体脂率比体重更该关注

- 成本：可能需要体脂秤或皮脂钳
- 说人话：同样 60 kg，一个体脂 20%、一个 30%，体型和健康天差地别。体重正常但体脂高（"瘦胖子"）也要管
- 收益：建立更对的指标
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：体脂率/腰围是比 BMI 更贴近健康风险的指标
- 备注：家用体脂秤误差不小，看趋势别看绝对值

12. 一周看趋势，别天天被秤绑架

- 成本：零
- 说人话：固定时间（晨起空腹）称，记下来，看 7 天平均线。一天起伏当没看见
- 收益：心态稳，才走得远
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：体重监测行为干预建议
- 备注：配合每周拍一张同角度照片，比秤更直观

2. 你到底胖不胖，先量再减

不是所有"觉得自己胖"都需要减，也不是所有 BMI 正常的人都安全。这一节给你三把尺子：BMI、腰围、体脂率，以及几个最容易误判的场景。

1. BMI 的中国标准：24 是分水岭

- 成本：零，会除法就行
- 说人话：BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)的平方。中国标准：18.5–23.9 正常，24–27.9 超重，≥28 肥胖。比欧美（25 起）更严，因为中国人同样的 BMI 内脏脂肪更多
- 收益：先知道自己落在哪个区，再决定要不要减
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国成人超重肥胖判定标准（WS/T 428 等）及肥胖症诊疗指南(2024)
- 备注：这是全国通用的筛查切点

2. 腰围比 BMI 更预警中心性肥胖

- 成本：一根软尺
- 说人话：即使 BMI 正常，如果男腰围 ≥90 cm、女 ≥85 cm，内脏脂肪已经偏多，糖尿病、心血管病风险明显升高
- 收益：很多"BMI 正常但小肚子大"的人，这项会亮红灯
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国中心性肥胖标准（男 ≥90 cm、女 ≥85 cm）
- 备注：量是脐周水平，别量裤腰

3. 体脂率：男 >25%、女 >32% 算肥胖

- 成本：体脂秤/皮脂钳或体测仪
- 说人话：体重称不出脂肪占比。一般男性体脂 >25%、女性 >32% 即属肥胖范畴，肌肉多的人 BMI 高但体脂可能很低
- 收益：区分"壮"和"胖"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：体脂率肥胖切点参考值
- 备注：健身增肌者别被 BMI 吓到

4. 儿童不能用成人 BMI 切点

- 成本：零
- 说人话：孩子要用"年龄别 BMI 百分位"。而且儿童减重目标是"让体重增速慢于身高增速"，不是成人式的拼命掉秤
- 收益：别用错标准坑了孩子
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国儿童青少年超重肥胖筛查标准（不同性别年龄百分位）
- 备注：儿童不适合轻断食、不适合极端节食

5. 孕妇、健身增肌者 BMI 会"假高"

- 成本：零
- 说人话：肌肉比脂肪重，撸铁的人 BMI 容易飘到"超重"；孕妇本就该增重。这类"高 BMI"不是肥胖
- 收益：别被单一数字误判
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：体成分差异对 BMI 的影响
- 备注：看腰围和体脂更准

6. 老年人轻度超重可能反而更稳

- 成本：零
- 说人话：一些观察研究发现，65 岁以上人群 BMI 在 24–26 左右、略超标准，全因死亡风险反而低于过瘦者。但这不等于可以放任
- 收益：老人别盲目追求"瘦"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：老年肥胖与死亡风险的流行病学研究（U 形/J 形关系）
- 备注：老人重点是防肌少，不是单纯降体重

7. 不是所有"胖"都要减，先看合并症

- 成本：零
- 说人话：如果 BMI 刚到 24，但血压、血糖、血脂、尿酸、睡眠呼吸都正常，运动习惯也好，未必急着减；反过来 BMI 正常但腰围大、指标差，也要管
- 收益：把决策从"看秤"转到"看健康"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：肥胖相关合并症风险评估思路
- 备注：指标比数字更说明问题

8. 家用体脂秤误差大，看趋势别看绝对值

- 成本：买个体脂秤
- 说人话：生物电阻抗法受喝水、进食、脚湿影响很大，同一天能差好几个点。DXA 或皮脂钳更准，但家用就当"看方向"用
- 收益：不被假精确误导
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：BIA 测量误差来源文献
- 备注：固定时间、同样状态测，才有可比性

9. 你"没吃多"可能是错觉：自我报告平均低估 30%

- 成本：零
- 说人话：2019 年系统综述发现，超重肥胖人群自报食量平均比实际低约 30%——零食、油、调料、饮料最容易被忘。所以"我吃得很少还不瘦"常是漏记
- 收益：打破自我设限，先真实记两周
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：J Acad Nutr Diet 2019 系统综述（自我报告能量摄入低估）
- 备注：用食物秤 + App 记，比凭感觉准得多

10. 先算 TDEE，再定目标热量

- 成本：零，用公式或在线计算器
- 说人话：TDEE 是你一天总消耗。减重建在"目标 = TDEE 500~750 kcal"上。不知道自己烧多少就瞎减，很容易减进代谢坑
- 收益：让计划有依据
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：Mifflin-St Jeor 等 BMR 公式 + 活动系数
- 备注：算出后别长期低于 1200 kcal（女）/1500 kcal（男）

11. 固定时间称：晨起空腹、排便后

- 成本：零
- 说人话：每天同一状态称，数据才有可比性。晨起、上完厕所、空腹、穿同样衣服，记一个数就行
- 收益：数据干净，趋势才看得清
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：体重监测方法建议
- 备注：配合第 1 节"看周趋势"

12. 记录三条基线，三个月后回头看

- 成本：零
- 说人话：开工前记三样：体重、腰围、最近一次体检的关键指标（血糖血脂血压肝功）。三个月后对比，比天天盯秤有说服力
- 收益：用事实而非感觉判断进展
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：行为干预基线评估建议
- 备注：拍照同角度同光也行

3. 七种医学减重膳食，中国指南逐一看

2024 年中国首部《肥胖症诊疗指南》一次性列出了 7 种医学减重膳食。它们不是"谁更好"，而是"谁更适合你、能坚持"。这一节把每种的吃法、适用人和短板讲清楚。

1. 限能量饮食（CRD）：最稳的 baseline

- 成本：要算热量、改习惯
- 说人话：在日常饮食基础上每天减 500–1000 kcal（或减 30%），但营养比例正常（碳水 55%–60%、蛋白够、脂肪 25%–30%）。最经典、最不容易出事
- 收益：几乎所有指南都把它当首选
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国肥胖症诊疗指南(2024)「限能量饮食」条目 https://xhyxzz.pumch.cn/article/doi/10.12290/xhyxzz.2024-0918
- 备注：适合所有人，尤其新手从这里起步

2. 轻断食 5+2：不用天天算

- 成本：每周两天"少吃"
- 说人话：一周 5 天正常吃，挑不连续的 2 天只吃约 1/4 能量（男 600、女 500 kcal）。好处是"只有两天要克制"，其余日子不绷着
- 收益：依从性往往比每天算热量好
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：中国指南「轻断食/间歇性能量限制」条目（5+2 模式）
- 备注：那两天也别完全不吃，吃蛋白+蔬菜扛饿

3. 低碳 / 生酮：短期掉秤快，但难坚持

- 成本：要戒主食、买替代
- 说人话：碳水供能比压到 20%–40%（<20% 算极低碳/生酮）。短期因为排水+抑制食欲掉得猛，但长期和别的法拉平，且难长期坚持，要监测酮体、糖尿病人慎用
- 收益：适合短期想看到变化、能忍的人
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：中国指南「低碳水化合物饮食」条目
- 备注：别长期极低碳，电解质和情绪都容易出事

4. 高蛋白饮食：护肌、扛饿，但不宜久

- 成本：多吃蛋奶肉豆制品
- 说人话：蛋白供能比 >20% 且 <35%。在限能量时最能保住肌肉、增加饱腹，适合短期快速减或减后维持
- 收益：和"守住肌肉"直接挂钩，见第 5 节
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：中国指南「高蛋白饮食」条目（不建议长期，监测肾功能）
- 备注：肾功能异常者别用

5. 低脂饮食：适合脂代谢异常的人

- 成本：要避开油炸和肥肉
- 说人话：脂肪供能比压到 20%–25%（或全天 <50 g）。对合并高血脂、脂肪肝的人有针对性，但注意别用精制碳水补位
- 收益：脂代谢异常人群的针对性选择
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：中国指南「低脂饮食」条目
- 备注：低脂 ≠ 低卡，碳水超了照样胖

6. 代餐饮食：依从性好，但别全代

- 成本：买代餐产品
- 说人话：用低卡高纤易饱的代餐替 1–2 餐，控制能量密度很方便，研究发现对长期减重有帮助。但完全代餐会降低生活质量，还要防营养不良
- 收益：忙碌人群的省心选项
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：中国指南「代餐饮食」条目
- 备注：选有完整营养的代餐，别拿"代餐奶昔当水喝"

7. 极低能量饮食（600–800 kcal）：只给重度肥胖短期用

- 成本：几乎只吃医学配餐
- 说人话：每天只 600–800 kcal，保留最低蛋白和碳水，用于重度肥胖的快速减重，但必须严格医学监督，防营养不良和低代谢，绝不长期用
- 收益：重度肥胖的医疗手段，不是网红断食
- 证据等级：A
- 风险：高
- 来源：中国指南「极低能量饮食」条目（仅短期、医学监督）
- 备注：自己千万别在家试

8. 没有"最好"的膳食，只有"能坚持"的

- 成本：零
- 说人话：指南列 7 种，潜台词就是"都有效，关键看你吃得下去、吃得久"。挑一个能陪你一辈子的，而不是最狠的
- 收益：终结"哪种饮食最神"的内耗
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：多项头对头试验结论（见第 4 节）
- 备注：换法比换命容易，别在一棵树上吊死

9. 碳水 55%–60% 是限能量的推荐比例

- 成本：零
- 说人话：限能量饮食里，碳水不是敌人，供能比约 55%–60% 是平衡方案；全砍碳水往往带来酮症、便秘、情绪差
- 收益：别被"碳水有害"带偏
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：限能量平衡膳食的宏量比例建议
- 备注：选全谷物，别选精白米面

10. 膳食纤维：天然饱腹剂

- 成本：多吃蔬菜豆薯
- 说人话：蔬菜、豆类、粗粮的纤维让你"吃了有饱感、血糖不坐过山车"，是限能量饮食里最便宜的助攻
- 收益：饱腹 + 稳糖，一举两得
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：膳食纤维与饱腹、血糖控制的证据
- 备注：猛加纤维会胀气，循序渐进

11. 地中海饮食：长期健康加分项

- 成本：以橄榄油、鱼、蔬果、全谷为主
- 说人话：不是专门为了减重，但它是循证上"对心血管最友好"的饮食模式，减重的长期维持阶段尤其值得借鉴
- 收益：把减重和长寿绑在一起
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：PREDIMED 等研究支持地中海饮食的心血管获益
- 备注：可作为减后的"终身吃法"

12. 所有医学膳食的尽头都是"长期习惯"

- 成本：零
- 说人话：指南反复强调：这些膳食有效的前提是"长期改变生活习惯"。减完就回老样子，所有法都会弹回去
- 收益：把预期摆正，省得白折腾
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国指南各膳食条目均注"需长期改变生活习惯"
- 备注：见第 8 节反弹与维持

4. 饮食法头对头，没有神

每年都有新饮食法封神，但放到严格随机试验里比，结论往往很扫兴：长期减重差异不大。这一节用几个经典头对头研究，把"哪种法最神"的神话拆掉。

1. DIETFITS：低脂 vs 低碳，一年没分出胜负

- 成本：零
- 说人话：2018 年斯坦福 609 人随机试验，按基因型和胰岛素灵敏度分组后，低脂和低碳饮食 12 个月减重无显著差异（都约减 5–6 kg）。"适合你的体质选法"也没被证实
- 收益：别再纠结"我该低脂还是低碳"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：Gardner et al., JAMA 2018（DIETFITS）
- 备注：决定结果的不是"哪种法"，而是能不能坚持

2. POUNDS LOST：四种宏量比例，一年都差不多

- 成本：零
- 说人话：同一团队把蛋白/脂肪/碳水的不同比例组合随机分组，2 年下来各组减重相近。比例不是胜负手
- 收益：把注意力从"比例"移到"总热量和坚持"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：Sacks et al., NEJM 2009（POUNDS LOST）
- 备注：高蛋白组在保肌上略好，见第 5 节

3. 关键变量是"依从性"，不是"哪种法"

- 成本：零
- 说人话：几乎所有头对头试验最后都指向同一条：谁能把方案执行得更久，谁掉得多。饮食法的"优劣"被依从性完全盖过
- 收益：选容易坚持的，而非理论上最狠的
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：饮食干预依从性与减重结局的汇总证据
- 备注：这解释了第 3 节"没有最好只有能坚持"

4. 生酮短期优势，多来自排水和食欲抑制

- 成本：零
- 说人话：生酮前几周掉得快，很大程度是糖原和绑定的水（每克糖原带约 3 g 水）。加上酮体抑制食欲，短期很爽，但长期水分回归、依从崩了，优势就拉平
- 收益：看懂"前两周掉 5 斤"的真相
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：极低碳水早期体重下降的机制解释
- 备注：别把排水当燃脂

5. 高蛋白在所有法里都有帮助

- 成本：零
- 说人话：不管你选低脂还是低碳，把蛋白吃够（1.2–1.5 g/kg）都能更好保肌、更扛饿。它是跨饮食法的"通用 buff"
- 收益：给你一个不用纠结也能赢的动作
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：高蛋白在体重管理中的一致性获益证据
- 备注：详见第 5 节

6. 地中海饮食赢在终点，不在秤上

- 成本：零
- 说人话：地中海饮食的强项不是"掉秤最快"，而是 PREDIMED 等研究证明它能降低心血管事件、改善长期生存。减重是副产品
- 收益：把"吃得对"和"活得长"接上
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：PREDIMED 随机试验（地中海饮食一级预防）
- 备注：适合减后维持期

7. 断食 ≠ 节食：5+2 的优势是"不用天天算"

- 成本：零
- 说人话：间歇性能量限制和"天天少吃"在总缺口相当时减重相近，但它把克制压缩到每周两天，心理负担小，所以有些人更能坚持
- 收益：给"算热量算到崩溃"的人另一条路
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：间歇性能量限制 vs 持续限能量的对照研究
- 备注：见第 3 节

8. 警惕"某某饮食治愈 XX"的过度宣传

- 成本：零
- 说人话：生酮"治糖尿病"、断食"逆转衰老"这类说法，常把短期指标改善夸成"治愈"。指标变好是真的，但话术往往越界
- 收益：不被标题党带节奏
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：对饮食法健康声明的证据分级审查
- 备注：看原始研究，别看二手营销

9. 素食不自动等于减重

- 成本：零
- 说人话：素食如果靠油炸、甜点、精制碳水填肚子，热量一样爆。植物性饮食有益健康，但不等于"吃素就能瘦"
- 收益：破除一个常见误会
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：素食与体重关系的观察研究
- 备注：看总热量和加工程度

10. 液体热量是最易忽略的超标源

- 成本：零
- 说人话：奶茶、果汁、含糖咖啡，一杯 300–500 kcal 像喝水一样进去了，饱腹感却几乎没有。很多人"吃很少"却瘦不下来，漏在这
- 收益：一个动作就能砍掉大缺口
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：含糖饮料与体重增加的循证关联
- 备注：换成白水/无糖茶，立竿见影

11. 餐盘法比算热量更可持续

- 成本：零
- 说人话：每餐半盘蔬菜、四分之一蛋白、四分之一全谷，不用秤不用 App 也能大致控量。对大多数人比天天算热量活得下去
- 收益：把减重融入生活而非变成功课
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：餐盘法（MyPlate 类）在体重管理中的应用
- 备注：作为长期维持的默认模式很合适

12. 结论：选一个能陪你一辈子的，不是最狠的

- 成本：零
- 说人话：头对头研究的一致结论是——长期减重看坚持，不看流派。找个你吃得下、吃得起、吃得了很久的方案，就是对你最好的饮食法
- 收益：终结选择焦虑
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：饮食法比较的系统性结论
- 备注：下一节把"守住肌肉"单独拎出来讲

5. 蛋白质与饱腹，守住肌肉

减重最怕的不是掉得慢，是掉肌肉。这一节专讲怎么用蛋白质把"掉的重"尽量留成脂肪的减少、肌肉的保留——这是长期不反弹的核心。

1. 减重期蛋白吃到 1.2–1.5 g/kg 理想体重

- 成本：多吃蛋奶肉豆
- 说人话：按你的"理想体重"（不是现在体重）每公斤吃 1.2–1.5 g 蛋白。比如理想 60 kg，一天约 72–90 g 蛋白，分在三餐
- 收益：保肌、扛饿、少掉代谢
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国营养学会及国际减重期蛋白摄入建议（1.2–1.5 g/kg）
- 备注：健身/老年人可到 1.5–2.0 g/kg

2. 蛋白质的热效应最高，吃它更"费热"

- 成本：零
- 说人话：消化蛋白本身要消耗其热量的 20%–30%，碳水约 5%–10%、脂肪最低。吃蛋白比吃油"净赚"热量少
- 收益：同样是 100 kcal，蛋白更划算
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：食物热效应（TEF）研究
- 备注：锦上添花，不是主因

3. 蛋白最扛饿，降低暴食概率

- 成本：零
- 说人话：蛋白能刺激饱腹激素、压住饥饿激素，吃完两小时还不想吃。相比之下白粥、甜点撑不过一小时
- 收益：从源头减少"忍不住"的时刻
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：蛋白摄入与饱腹感/食欲调节的研究
- 备注：每餐先吃蛋白再吃主食

4. 每减 5% 体重，代谢约降 100 kcal，要重算

- 成本：零
- 说人话：体重下来了，身体消耗也下来了。掉 5% 体重，静息代谢大约少烧 100 kcal/天，不调整摄入就会卡在平台。这是数学，不是你的问题
- 收益：解释并解决"减着减着不动了"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：减重期代谢适应（adaptive thermogenesis）量化研究
- 备注：见第 7 节平台期

5. 力量训练 + 蛋白，把掉的重留成脂肪减少

- 成本：办卡或在家练
- 说人话：光少吃会同时掉肌和脂；加上抗阻训练和够蛋白，掉的主要是脂肪，肌肉尽量留住。肌肉留住 = 代谢留住 = 不反弹
- 收益：这是"减对了"和"减垮了"的分界线
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：抗阻训练在减重期保肌的随机研究
- 备注：见第 6 节运动

6. 老年人更要高蛋白防肌少

- 成本：多吃优质蛋白 + 维 D
- 说人话：老人减重最危险的不是胖，是"少肌性肥胖"。蛋白 ≥1.2 g/kg 再加维 D 800–1000 IU/天，能护住功能
- 收益：老人减重的安全底线
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：老年少肌症防治建议
- 备注：配水中行走、弹力带更护关节

7. 优质蛋白来源：蛋、禽、鱼、豆制品

- 成本：正常买菜
- 说人话：鸡蛋、鸡胸、鱼虾、豆腐、无糖酸奶都是便宜又完整的蛋白。红肉适量，加工肉（香肠培根）少碰
- 收益：性价比最高的"保肌弹药"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：膳食蛋白来源与质量的营养学证据
- 备注：植物蛋白搭配谷物更全

8. 乳清/蛋白粉是便利补充，不是必须

- 成本：买粉
- 说人话：如果你正餐吃不够蛋白，粉是方便的补充；但能靠天然食物吃够，完全不需要粉。别把粉当"减肥药"神化
- 收益：少花冤枉钱
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：蛋白补充剂的定位说明
- 备注：看配料表，别买加了糖和乱七八糟的

9. 蛋白过多（>35%）对肾有负担

- 成本：零
- 说人话：指南把高蛋白上限划在 35% 供能比，长期超量、尤其肾功能本来不佳的人，会增加肾脏滤过负担
- 收益：别从一个极端跳到另一个
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：中国指南高蛋白饮食"监测肾功能"提示
- 备注：普通人按 1.2–1.5 g/kg 足够

10. 三餐都分点蛋白，比一顿猛吃更吸收

- 成本：零
- 说人话：肌肉合成是"分次触发"的，每餐 25–40 g 优质蛋白比晚餐一顿塞 80 g 利用率高
- 收益：同样蛋白，效果更好
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：蛋白质分次摄入与肌肉蛋白合成速率研究
- 备注：早餐常被忽略，最该补蛋白

11. 平台期常是"蛋白不够 + 有氧太多"的组合

- 成本：零
- 说人话：很多人卡平台，是因为疯狂有氧、蛋白却没吃够，肌肉掉、代谢降，缺口自己消失。把蛋白提上来、加抗阻，往往就破了
- 收益：直击最常见的卡顿原因
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：减重平台期成因分析
- 备注：见第 7 节

12. 肌肉掉 1 kg ≈ 每天少耗 70–100 kcal

- 成本：零
- 说人话：每公斤肌肉每天多烧约 70–100 kcal，掉 3 kg 肌肉等于你每天凭空少了 200–300 kcal 的消耗，这正是反弹的加速器
- 收益：一句话说清"为什么守住肌肉这么值"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：肌肉量与静息代谢关系的估算（每 kg 肌肉耗 70–100 kcal/天）
- 备注：所以第 1 节说"减重不等于减脂"

6. 运动的真实位置，不是主力是护城河

很多人把运动当成减重主力，结果练得脱力也没掉几斤，心态崩了。这一节把运动在减重里的真实角色摆正：它造缺口能力有限，但防反弹、保代谢、护健康的价值无可替代。

1. 运动不是减重主力，是"防反弹 + 健康"主力

- 成本：时间投入
- 说人话：靠运动凭空制造每天 500 kcal 缺口，得练一两个小时；靠少吃则容易得多。运动的头号价值是"减下来之后别弹回去"和"全身更健康"
- 收益：摆正预期，不白练也不灰心
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：运动在体重管理中的定位（造缺口弱、维持强）
- 备注：和饮食是分工关系，不是替代

2. 有氧 ≥150 min/周，维持期 200–300 min

- 成本：中等时间
- 说人话：快走、游泳这类中等强度有氧，每周至少 150 分钟（约每天 30 分钟、多数天）；要长期维持体重，加到 200–300 分钟/周效果更好
- 收益：循证的运动底线
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：肥胖管理指南及体力活动建议（有氧 150 min；维持 200–300 min）
- 备注：分多次也行，不必一次搞定

3. 抗阻 2–3 次/周，保肌提代谢

- 成本：器械或自重
- 说人话：深蹲、硬拉、俯卧撑这类练大肌群，每周 2–3 次。它直接对抗肌肉流失、撑住基础代谢，是减重期最该做、却最常被跳过的运动
- 收益：把第 5 节的"保肌"落到动作
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：抗阻训练在减重保肌中的核心地位
- 备注：新手从自重/弹力带起步，别上来硬扛大重量

4. 单纯靠运动减重有限

- 成本：零
- 说人话：大量研究一致显示：只加运动、不改饮食，一年也就掉几斤，因为身体会用"少动其他时候""吃回来一点"补偿。别指望只练不忌
- 收益：避免"我天天练还不瘦"的挫败
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：单纯运动干预的减重幅度证据
- 备注：运动和饮食一起上才放大

5. HIIT 时间短效率高，但新手别硬上

- 成本：高强度、短时长
- 说人话：高强度间歇（比如冲刺 20 秒 + 走路 40 秒）能在更短时间内给代谢刺激，还有运动后过量氧耗（EPOC）。但心肺基础差、关节不好的人容易受伤，循序渐进
- 收益：时间紧的人的高效选项
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：HIIT 与持续有氧的减重/心肺对比研究
- 备注：每周 1–2 次足矣，别天天冲

6. NEAT：多站多走，每天多耗 300 kcal 很常见

- 成本：习惯微调
- 说人话：通勤骑车、爬楼、站着办公、家务，这些"非运动活动"累积起来，有人一天能比久坐者多烧 300 kcal 以上，而且零痛苦
- 收益：不练也能烧，是维持期神器
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：NEAT 作为消耗最大可变项的证据（见第 1 节）
- 备注：能走不坐、能站不躺

7. 力量训练增肌：每 kg 肌肉多耗 70–100 kcal/天

- 成本：时间 + 器械
- 说人话：肌肉是"代谢发动机"。练出几公斤肌肉，相当于身体 24 小时都在多烧点，是反弹最怕的东西
- 收益：把"易瘦体质"从玄学变成可练
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：肌肉量与静息代谢关系（见第 5 节第 12 条）
- 备注：和蛋白一起吃，效果才显

8. 运动降低复食后的反弹

- 成本：时间
- 说人话：减完回到正常吃，有运动习惯的人体重回弹明显更少。运动是维持期的"保险"
- 收益：给"减下来怎么守得住"一个答案
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：体力活动与减重维持的纵向证据
- 备注：这和第 8 节反弹直接挂钩

9. 久坐是独立危险因素，比"动得少"更糟

- 成本：零
- 说人话：即使总运动量达标，如果每天坐 10 小时，代谢和心血管风险还是高。"久坐"本身是个独立坏变量，和运动量分开算
- 收益：提醒你打断久坐，比多加一组动作还重要
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：久坐行为与代谢健康的独立关联证据
- 备注：每坐一小时起来晃两分钟

10. 膝盖不好选游泳/骑车，别硬跑步

- 成本：可能要场地
- 说人话：大体重或膝骨关节炎人群，跑步冲击大，改游泳、骑车、椭圆机更护关节。等体重下来再考虑跑步
- 收益：避免"为了减伤了膝"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：减重人群运动处方的关节保护建议
- 备注：先评估再动，见第 11 节

11. 动前最好做健康评估，尤其大体重/有慢病

- 成本：一次评估
- 说人话：心肺、血压、血糖、关节情况不明的，先让运动医学或康复科帮你定计划，比自己瞎练安全，也更容易坚持
- 收益：少走弯路、少受伤
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：运动前健康评估的常规建议
- 备注：医院运动医学科/康复科都做这个

12. 记录步数/心率，比"我感觉动了"靠谱

- 成本：手机或手环
- 说人话：人很容易高估自己动了多少。记步数（比如目标 8000–10000）、看心率区间，让"动了"变成可量化
- 收益：把模糊的努力变成数据
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：运动行为记录的有效性证据
- 备注：手环别只看卡路里，看趋势

7. 平台期与代谢适应，为什么减着减着不动了

体重卡住不是你意志力崩了，是身体在"省钱"。这一节讲清楚平台期的生理机制，以及怎么科学地破，而不是靠继续饿。

1. 平台期核心：身体代谢适应，主动降消耗

- 成本：零
- 说人话：体重下降时，身体会调低静息代谢、提高进食冲动，像"省电模式"对抗变瘦。这是写进生理程序的，不是你懒
- 收益：先卸下"我是不是废了"的心理包袱
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：代谢适应（adaptive thermogenesis）机制研究
- 备注：见第 5 节第 4 条量化

2. Biggest Loser 研究：极端减重后代谢长期低下

- 成本：零
- 说人话：那档减肥真人秀的追踪研究发现，选手们减掉大量体重后，静息代谢在多年后仍明显低于应有水平，且激素全面偏向"想多吃"。证明极端速减的后劲有多狠
- 收益：给"别求快"一个血淋淋的证据
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：Fothergill et al., Obesity 2016（Biggest Loser 长期代谢追踪）
- 备注：慢减、保肌，正是为了躲开这个坑

3. 体重调定点：下丘脑对抗体重下降

- 成本：零
- 说人话：大脑把你的"原体重"当成设定值，瘦下来就通过降代谢、升饥饿把你往回拉。这也是为什么维持和减重一样难
- 收益：理解"维持期"为什么需要长期策略
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：体重调定点（set point）理论及神经内分泌证据
- 备注：见第 8 节怎么对抗调定点

4. 每减 5% 体重，BMR 降约 100 kcal，要重算摄入

- 成本：零
- 说人话：体重降一截，你的"维持热量"也降一截。不减摄入，原来的缺口就自己消失了，于是平台。重算一下，缺口就回来了
- 收益：平台的第一解法，往往就是"重新算"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：减重期静息代谢下降的量化（见第 5 节）
- 备注：别靠继续砍餐次来破

5. 温和方案（0.5–1 kg/周）平台更轻

- 成本：零
- 说人话：慢慢减、兼顾均衡和力量训练，身体代谢适应更平稳，平台要么不来、要么短。激进节食则提前且持久地卡
- 收益：从源头减少平台
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：减重速率与代谢适应/平台的关系
- 备注：呼应第 1 节安全缺口

6. 破平台：换粗粮、加运动强度或频次

- 成本：微调习惯
- 说人话：真卡住了，不必推翻方案：把精白米面换成粗粮、把运动加点量或换个花样，给身体一点新刺激往往就动起来
- 收益：低痛感破局
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：平台期干预的常规建议
- 备注：别一次改太多，容易崩

7. 平台期其实是"减脂增肌黄金期"

- 成本：零
- 说人话：秤不动时，体脂率可能还在降、腰围在缩、体能在上。身体的成分正在重组，这是好事，不是卡死
- 收益：换个指标看，心态不崩
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：平台期体成分变化的现象描述
- 备注：量腰围、看照片比盯秤有用

8. 连续 2 周不动 = 缺口没真实形成，先查摄入

- 成本：零
- 说人话：体重两周纹丝不动，第一反应不是"代谢坏了"，而是"其实吃的比记的多"。回去真实称量记录两周，十有八九就破案
- 收益：少走"乱加运动量"的弯路
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：自我报告低估与减重阻力的关联（见第 2 节第 9 条）
- 备注：食物秤比运动补缺口省事

9. 睡眠 <6 h 会升饥饿素、降瘦素

- 成本：零
- 说人话：睡不够，身体会多分泌饥饿素、少分泌瘦素，对高热量食物的渴望直线上升。睡差的人减得慢、反弹快，不是巧合
- 收益：把"好好睡觉"纳入减重方案
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：睡眠剥夺与食欲激素/食物渴望的研究
- 备注：见第 8 节睡眠与维持

10. 碳水循环 / HIIT 破适应（证据 B）

- 成本：要规划
- 说人话：几天低碳 + 一天中等碳水的循环，或穿插 HIIT，给代谢一点"不确定刺激"，有助于打破身体的适应性。证据中等，算可选手段
- 收益：给卡很久的人一个进阶选项
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：碳水循环/HIIT 对代谢适应的干预研究
- 备注：新手优先用第 6 条的基础调整

11. 别靠继续砍餐次破平台，会丢肌肉

- 成本：零
- 说人话：越卡越少吃，是最常见也最糟的反应：肌肉掉得更快、代谢更低，下次更难。平台要"调结构"不是"加减法"
- 收益：避开最坑的破局方式
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：极低热量与肌肉流失/代谢下降的关系
- 备注：反方向：提蛋白 + 加抗阻

12. 平台期心态：看围度、体能，不只看秤

- 成本：零
- 说人话：把评估指标从"公斤数"扩成腰围、体脂趋势、爬楼不喘、衣服变松。多维度的正向反馈，才撑得过平台
- 收益：心态稳，才走得完
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：多维体重管理评估建议
- 备注：每周固定拍同角度照

8. 反弹为什么发生，怎么防

减重界有个扎心事实：大部分人减下来的体重，会在 1–3 年里部分弹回。这一节讲反弹的生理机制，以及真正能把成果留住的动作。

1. 多数减重 1–3 年部分反弹，生活方式干预尤其明显

- 成本：零
- 说人话：系统综述显示，单纯生活方式干预平均减约 7.4%，但约 4 年内往往回弹大半。这不是你不行，是生理 + 环境双重拉扯
- 收益：把"反弹"从羞耻变成"可管理的风险"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：ASBMS/系统综述对生活方式干预减重与反弹的汇总（2020–2024）
- 备注：所以"减下来"只是上半场

2. 调定点：停减后饥饿素↑、瘦素↓，身体想回原重

- 成本：零
- 说人话：瘦下来后，大脑把"原体重"当默认值，于是让你更饿、更省电，拼命把你拉回去。这是反弹的生理发动机
- 收益：理解为什么"保持"比"减"难
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：体重调定点与减重后神经内分泌反弹（见第 7 节）
- 备注：对抗它的办法在第 4–8 条

3. 维持期继续称体重：每周 1–2 次，反弹 >5% 回方案

- 成本：零
- 说人话：减完别把秤收起来。每周固定称 1–2 次，一旦发现比最低点回弹超过 5%，立刻回到干预方案，别等弹回 10%
- 收益：把小反弹掐死在萌芽
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：自我称重与减重维持的随机试验证据
- 备注：配合食物日记效果更好

4. GLP-1 停药反弹明显，是长期药不是"疗程"

- 成本：药费
- 说人话：SURMOUNT-4 试验里，停掉替尔泊肽换成安慰剂的那组，36 – 88 周内体重回涨约 14%。说明这类药像降压药——用着有效，停了容易回
- 收益：用药前就接受"可能是长期管理"的现实
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：SURMOUNT-4 维持/停药试验（停药组反弹约 14%）
- 备注：详见第 9 节

5. 手术效果最持久，10 年仍维持约 25% 减重

- 成本：手术费用 + 风险
- 说人话：减重手术（袖状胃/胃旁路）1 年减总体重约 30%，并能在 10 年后仍维持约 25% 的下降，是所有手段里最持久的
- 收益：给"什么最不容易弹"一个答案
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：ASMBS 2024 系统综述（手术 10 年维持约 25% 体重下降）
- 备注：但手术也要配合长期行为管理

6. 蛋白质 + 抗阻，是防反弹的硬核组合

- 成本：时间与食材
- 说人话：守住肌肉 = 守住代谢。减完保持高蛋白和规律力量训练的人，反弹幅度明显更小。这是少数"写在证据里"的防弹手段
- 收益：把"不反弹"从玄学变成训练计划
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：肌肉量/抗阻训练与减重维持的关联证据
- 备注：和第 5、6 节一脉相承

7. 睡眠 7–9 h、管压力（皮质醇→腹部脂肪）

- 成本：零
- 说人话：睡不够和第 7 节讲的一样会拉高饥饿素；长期高压让皮质醇升高，脂肪爱往肚子堆。睡好、稳住情绪，是隐形的防反弹
- 收益：两个不花钱的关键动作
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：睡眠/压力与体重维持的关系研究
- 备注：情绪性进食严重者建议转心理科

8. 行为记录（食物日记）长期有效

- 成本：每天几分钟
- 说人话：减完继续记食物日记或 App 打卡的人，维持成绩显著更好。记录本身就有"刹车"作用，防你悄悄回到老习惯
- 收益：低成本、高回报的维持习惯
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：自我监测与减重维持的证据
- 备注：记"趋势"即可，别变强迫

9. 设定"维持热量"目标，不只"减重热量"

- 成本：零
- 说人话：减到目标后，要切换到"维持热量"（比减重期高 300–500 kcal），而不是一直饿着。一直饿着必然崩，过渡到维持才是正解
- 收益：很多反弹源于"减完还在挨饿"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：减重后维持期能量摄入的阶梯建议
- 备注：用第 2 节算出的 TDEE 当锚

10. 反弹不是失败，是信号——调方案而非自责

- 成本：零
- 说人话：回弹 2–3 kg 很正常，是身体在提醒"最近缺口没了/压力大了"。把它当数据看，调回来就行，别上升到"我没毅力"
- 收益：切断羞耻感，才能长期跑
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：行为心理学对体重维持挫折的建议
- 备注：见第 12 节避坑

11. 社交支持（家庭共餐盘、减重群）降低脱落

- 成本：零
- 说人话：一个人改习惯很难，全家一起调整餐盘、或加入靠谱减重社群，脱落率明显降低。环境对了，你才不孤单
- 收益：把"靠自律"变成"靠环境"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：社会支持与体重管理依从性的研究
- 备注：别进卖产品的群，进交流经验的

12. 把减重当成"新生活习惯"，不是"阶段性项目"

- 成本：零
- 说人话：最稳的防反弹，是承认这辈子都要吃得聪明、动得规律，而不是"减完就解放"。把健康吃法当成你的新常态
- 收益：从根上回答"怎么不反弹"
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：长期体重管理的核心结论
- 备注：呼应第 3 节"结束于长期习惯"

9. 减重药物，GLP-1 与奥利司他

当饮食运动走到瓶颈，药物是循证指南里的正规选项，不是走投无路。这一节讲清楚目前证据最硬的几类药、谁该用、以及停药反弹的真相。

1. GLP-1（司美/替尔泊）：目前减重的"最强药物"

- 成本：药费较高
- 说人话：这类药通过中枢降低饥饿、增加饱腹，让你自然少吃。在减重药里，它是目前循证最强、降幅最大的一类
- 收益：给"靠自己实在难"的人一个硬核选项
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：GLP-1 受体激动剂的减重证据（见下两条 RCT）
- 备注：属处方药，需医生评估开方

2. STEP 1：司美格鲁肽 68 周减重约 14.9%

- 成本：药费
- 说人话：STEP 1 试验里，2.4 mg 司美格鲁肽 + 生活方式干预 68 周，平均减重 14.9%，安慰剂组仅 2.4%。这是头对头安慰剂里非常扎实的数字
- 收益：知道它"到底能减多少"，不被营销夸张
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：Wilding et al., NEJM 2021（STEP 1），减重 14.9% vs 2.4%
- 备注：所有 participant 都同时做饮食运动，药是"叠加 buff"

3. SURMOUNT-1：替尔泊肽 72 周最高减重 20.9%

- 成本：药费
- 说人话：替尔泊肽（双靶点）在 15 mg 组 72 周平均减重 20.9%，安慰剂 3.1%，是目前药物里降幅最大的之一
- 收益：了解"天花板"在哪
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：SURMOUNT-1（替尔泊肽）72 周减重 20.9% vs 3.1%
- 备注：不同药头对头（SURMOUNT-5）也显示替尔泊肽优于司美

4. GLP-1 减重的 25%–39% 是瘦体重，要配蛋白+运动

- 成本：零（靠饮食运动对冲）
- 说人话：研究发现 GLP-1 减掉的重量里，有 25%–39% 是肌肉而非脂肪。如果不主动补蛋白、做抗阻，掉的主要是肌，代谢跟着垮
- 收益：用药也别放弃第 5、6 节的动作
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：STEP-1/SURMOUNT-1 中瘦体重流失占比分析
- 备注：这是被很多人忽略的用药代价

5. 停药反弹明显，是"长期管理"不是"疗程"

- 成本：长期药费预期
- 说人话：SURMOUNT-4 显示停换安慰剂后 36–88 周回涨约 14%。它更像降压药——用着控得住，停了易回。决定用药前先接受这点
- 收益：避免"用几个月就停、结果白减"的落差
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：SURMOUNT-4 维持/停药试验（见第 8 节）
- 备注：是否长期用，和医生共同决策

6. 用药指征：BMI≥28，或 ≥24 合并并发症

- 成本：就医评估
- 说人话：中国指南明确：BMI≥28，或 BMI≥24 且合并高血压、糖尿病、脂肪肝、睡眠呼吸暂停等并发症，才考虑联合药物治疗。不是想瘦就能开
- 收益：明确"谁该用"，也避免健康人滥用
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国肥胖症诊疗指南(2024)药物干预指征 https://xhyxzz.pumch.cn/article/doi/10.12290/xhyxzz.2024-0918
- 备注：必须由内分泌/减重专科评估

7. 奥利司他：唯一 OTC，减约 3.1%，但排油

- 成本：药费 + 低脂饮食配合
- 说人话：它抑制脂肪吸收约三成，是不用处方就能买的减肥药，平均多减约 3.1%。代价是吃油多了会"排油"、腹胀，得配合低脂
- 收益：给不想/不适合 GLP-1 的人一个温和选项
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：中国指南药物表（奥利司他减重 3.1%，常见腹胀脂肪泻）
- 备注：OTC 也要按说明，别当糖吃

8. 纳曲酮/安非他酮复方：作用于奖赏中枢

- 成本：药费
- 说人话：这个复方通过下丘脑减少"进食奖赏"，平均减重约 5% 级，适合伴有情绪性进食倾向的人，属于处方药
- 收益：给"总想吃东西"的人一个针对性选择
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：减重药物证据（纳曲酮/安非他酮复方）
- 备注：有癫痫史等禁忌，需医生把关

9. 12 岁以上肥胖青少年也可在医生监护下用药

- 成本：就医评估
- 说人话：STEP TEENS 显示 12–17 岁肥胖青少年用司美 68 周 BMI 降约 16.1%（安慰剂 0.6%），安全性与成人相当。但必须儿科/内分泌严格评估，绝不可自行用药
- 收益：给重度肥胖青少年的正规路径
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：STEP TEENS 试验（青少年司美减重 16.1% vs 0.6%）
- 备注：儿童首选仍是生活方式，药是补充

10. 严禁非正规渠道购药

- 成本：省钱冲动
- 说人话：GLP-1 热度下，假货、错剂量、无冷链的"代购"泛滥，轻则无效、重则低血糖/甲状腺风险。只在正规医疗机构和药房拿药
- 收益：保命，也保钱包
- 证据等级：A
- 风险：高
- 来源：GLP-1 类药物流通安全警示
- 备注：见第 12 节避坑

11. 药物不替代饮食运动，是"叠加 buff"

- 成本：零（认知）
- 说人话：所有 GLP-1 的旗舰试验里，参与者都同时做饮食和运动。药帮你"少吃"更容易，但底子还是健康生活。光吃药不改习惯，效果打折、反弹更快
- 收益：摆正药的位置
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：STEP/SURMOUNT 试验设计均含生活方式干预
- 备注：药 + 第 3–6 节方案 = 最优组合

12. 额外收益：司美降低主要心血管事件 20%

- 成本：药费
- 说人话：SELECT 试验显示，有心血管风险的超重/肥胖人群用司美，主要不良心血管事件（心梗、卒中、心血管死亡）降约 20%。减重之外，这是实打实的器官保护
- 收益：给"高风险人群该不该用药"多一个理由
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：SELECT 试验（司美降低 MACE 约 20%）
- 备注：是否适用，由心内/内分泌共同判断

10. 减重手术，谁该做，效果与风险

对重度肥胖，手术是循证上最有效、最持久的手段，但也带着真实风险和终身管理要求。这一节讲清指征、效果、代价，帮你在"该不该"这件事上不盲目。

1. 手术是重度肥胖最有效持久的手段

- 成本：手术费用 + 恢复期
- 说人话：2024 年系统综述比较了生活方式、GLP-1、手术：手术在减重幅度和持久度上都领先，是重度肥胖的"硬核选项"
- 收益：给"什么情况下该认真考虑手术"定调
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：ASMBS 2024 系统综述（手术 vs GLP-1 vs 生活方式）https://asmbs.org/articles/bariatric-surgery-more-effective-and-durable-than-new-obesity-drugs-and-lifestyle-intervention
- 备注：详见第 5 条长期数据

2. 袖状胃：1 年减总体重约 29.5%

- 成本：手术费
- 说人话：袖状胃切除是切掉大部分胃、做成细管，既缩小容量又降低饥饿激素。1 年平均减掉总体重的约 29.5%，是主流术式
- 收益：了解最常见的术式效果
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：ASMBS 2024（袖状胃 1 年总体重下降 29.5%）
- 备注：术后仍需长期饮食管理

3. 胃旁路（RYGB）：1 年约 31.9%，糖尿病缓解 80%+

- 成本：手术费 + 更高复杂度
- 说人话：胃旁路改变肠道走行和激素谱，1 年减总体重约 31.9%，2 型糖尿病缓解率 80% 以上，效果最猛但操作更复杂、营养风险更高
- 收益：了解"更狠"术式适合谁
- 证据等级：A
- 风险：高
- 来源：ASMBS 2024（胃旁路 1 年总体重下降 31.9%，糖尿病缓解率高）
- 备注：和外科充分权衡利弊

4. 指征：BMI≥32.5 强烈推荐；27.5–32.5 合并并发症推荐

- 成本：就医评估
- 说人话：中国专家共识：BMI≥32.5 强烈推荐手术；BMI 27.5–32.5 且合并糖尿病、高血压、睡眠呼吸暂停等肥胖相关并发症，也推荐。不是"胖就切"
- 收益：明确"谁该进手术室"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国减重代谢手术指征专家共识（BMI≥32.5 强烈推荐；27.5–32.5 合并症推荐）
- 备注：必须由多学科团队评估

5. 效果持久：10 年仍维持约 25% 体重下降

- 成本：零（结果维度）
- 说人话：和药停就弹不同，手术 10 年后还能维持约 25% 的总体重下降。这正是它"持久"的证据，也是对抗调定点的最强手段
- 收益：回答"反弹最怕谁"——手术
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：ASMBS 2024 长期随访（手术 10 年维持约 25% 体重下降）
- 备注：但维持也靠术后行为

6. 顺带改善：睡眠呼吸暂停 80%、脂肪肝、糖尿病

- 成本：零（获益维度）
- 说人话：手术不只是减重，睡眠呼吸暂停改善率约 80%，脂肪肝、血糖、血压也常明显好转，整体健康收益大
- 收益：看清手术的"全身回报"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：减重手术对肥胖相关合并症的改善证据
- 备注：这正是"治病"而非"美容"

7. 风险：手术有并发症，需严格评估

- 成本：风险认知
- 说人话：任何手术都有出血、吻合口瘘、疝、营养缺乏等风险，围手术期和终身都要注意。它有效，但不是"零代价"
- 收益：别把手术想成"懒人捷径"
- 证据等级：A
- 风险：高
- 来源：减重手术并发症与围术期风险数据
- 备注：选有资质的中心很关键

8. 术后要终身营养管理（缺铁、缺 B12 等）

- 成本：长期补充 + 随访
- 说人话：胃改造后铁、维 B12、钙等吸收受影响，很多人要终身补充、定期验血。忽视这点会贫血、骨质疏松
- 收益：提醒"手术不是一劳永逸"
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：减重术后营养缺乏与补充管理指南
- 备注：把随访当必修课

9. 适合年龄 18–70（中国专家）

- 成本：就医评估
- 说人话：中国专家共识推荐手术年龄一般在 18–70 岁之间，太年轻发育未定、太老风险升高，两端都要更谨慎
- 收益：划清适用年龄边界
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：中国减重代谢手术年龄建议
- 备注：青少年代谢手术有更严格指征

10. 不是"懒人捷径"，术前术后都要行为改变

- 成本：零（认知）
- 说人话：做了手术也得重新学吃、得运动、得随访。以为"切完随便吃"的人，复胖和并发症都更高。手术治"容量和激素"，不治"习惯"
- 收益：破除对手术的浪漫想象
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：术后行为依从性与结局的关系
- 备注：和心理/营养准备一起做

11. 与 GLP-1 对比：手术更彻底，药更可逆

- 成本：权衡
- 说人话：手术一次到位、持久，但不可逆、有创伤；药可逆、创伤小，但要长期用、停药易弹。两者不是替代，重度且合并症多的人，医生可能先药后术或联合
- 收益：帮你和医生聊清"选哪条路"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：手术与药物的定位差异（ASMBS 2024）
- 备注：决策个体化

12. 决策必须由多学科团队 + 本人评估，不可自行决定

- 成本：就医
- 说人话：手术涉及外科、内分泌、营养、心理多方评估，是严肃的医疗决策。任何"我上网看看就决定"都是错的，也别被机构营销推着走
- 收益：把决策权交回专业流程
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：减重手术适应证的多学科评估原则
- 备注：警惕只谈效果不谈风险的机构

11. 智商税清单，这些钱别花

减重是智商税最密集的领域之一。这一节把最常见、最会包装的坑逐一点名，省下的钱可能比减下的肉还多。

1. "排毒 / 清体餐"：身体自带肝肾，不需要排毒

- 成本：买套餐
- 说人话：″排毒″在医学上没有对应机制，你的肝和肾就是排毒系统。所谓清体餐，本质是短期少吃 + 灌肠感，掉的还是水和便
- 收益：别为不存在的概念买单
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：″排毒″无医学定义；肝肾承担解毒功能
- 备注：极端清体还可能电解质紊乱

2. 燃脂茶 / 减肥茶：多是泻药，掉的是水和便

- 成本：买茶
- 说人话：这类产品大多含番泻叶、决明子等泻下成分，让你拉肚子、少吸收一点，体重掉的都是水分和粪便，停了立刻回，长期还伤肠道
- 收益：认清″上厕所 ≠ 燃脂″
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：减肥茶常见含泻下成分，减重无持续证据
- 备注：见第 1 节第 10 条

3. 瘦身霜 / 束腰：不燃脂，束腰还伤肋

- 成本：买霜 / 束腰
- 说人话：抹在皮肤上的东西进不了脂肪层去″燃脂″；束腰只是把肉挤一块、暂时显瘦，长期勒着还可能影响呼吸和肋骨
- 收益：两个常见坑一并避开
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：外用减脂与束腰无循证效果
- 备注：按摩最多放松肌肉，不消脂

4. 局部减脂（仰卧起坐减肚子）：脂肪全身动员

- 成本：零
- 说人话：练哪块只壮哪块肌肉，脂肪是全身激素统一调动消耗的，不存在"练腹就掉肚腩"。想减肚子只能全身减 + 保肌
- 收益：拆掉最经典的局部谎言
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：局部减脂在严格研究中不成立（见第 1 节第 9 条）
- 备注：卷腹练的是腹肌，不是腰围

5. "负卡路里食物"：不存在

- 成本：零
- 说人话：没有任何天然食物的热量消耗能超过自身热量。芹菜低卡是真的，但"吃它反而掉肉"是假的
- 收益：省下专门为此多买的钱
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：食物热效应无负净效应（见第 1 节第 4 条）
- 备注：低卡可以吃，但别有幻想

6. 网红"断食 / 果汁 Cleanse"：本质节食 + 营销

- 成本：买 juice
- 说人话：几天只喝果汁或"净化液"，本质是极低热量节食，短期掉秤是水和肌，营养还单一，营销话术一整套
- 收益：别为"净化"二字付溢价
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：果汁 cleanse 的减重实为水分/肌肉流失
- 备注：真想轻断食，用第 3 节 5+2

7. 减肥贴 / 淋巴排毒：无证据

- 成本：买贴
- 说人话：贴在肚子上的"燃脂贴"、所谓"淋巴排毒"，都没有可靠研究支持能减脂。皮肤吸收那点成分，到不了脂肪
- 收益：别信"躺着瘦"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：外用/贴剂减脂缺乏循证
- 备注：带"排毒"二字的都先打问号

8. "代谢 boost"补剂（辣椒素等）：效果微乎其微

- 成本：买补剂
- 说人话：辣椒素、左旋肉碱等所谓"提升代谢"的补剂，临床上的额外消耗小到可以忽略，远不如少吃一口、多走一步
- 收益：把钱留给真正有效的（蛋白、蔬菜）
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：代谢类补剂的边际效应证据
- 备注：左旋肉碱在缺乏者身上才显效

9. 暴汗服 / 裹保鲜膜：掉水不是脂

- 成本：买暴汗服
- 说人话：裹着捂汗，秤上轻了是因为脱水，喝两杯水就回来，还容易中暑、皮肤问题。和燃脂毫无关系
- 收益：别被"出汗多 = 瘦得快"骗
- 证据等级：A
- 风险：中
- 来源：脱水与体重下降的区分
- 备注：运动该正常流汗，别刻意闷

10. 体脂秤"全身通电"广告：生物电阻抗误差大

- 成本：买秤
- 说人话：家用体脂秤的电阻抗法受饮水、进食、脚湿影响很大，绝对值别当真。当"看趋势"的工具还行，当"精准体检"就交了智商税
- 收益：买便宜的够用，别为噱头加价
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：BIA 测量误差来源（见第 2 节第 8 条）
- 备注：固定状态测才可比

11. "不运动不节食月瘦 20 斤"：必是极端或有害

- 成本：买方案 / 产品
- 说人话：健康减重在安全节奏下一个月也就 2–4 kg 脂肪。凡是承诺"不动不忌月瘦 20 斤"的，要么含药、要么极端节食、要么骗局，伤身没商量
- 收益：一条规则筛掉绝大多数坑
- 证据等级：A
- 风险：高
- 来源：安全减重速率（0.5–1 kg/周）的科学共识
- 备注：越夸张越要跑

12. 判定口诀：凡说"局部 / 不费力 / 速成"，先当坑

- 成本：零
- 说人话：脂肪只能全身减、减重需要缺口、健康没有捷径。任何方案同时满足"局部 + 不费力 + 速成"三特征，基本可以默认是智商税
- 收益：给你一把万能筛子
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：减重干预的基本科学约束
- 备注：拿这把尺子量所有广告

12. 避坑清单，最常见的减重误区

这一节把贯穿全书的坑收拢成一页"别做清单"。每条都对应前面某一节的硬道理，方便你临场自查。

1. 极端节食（<1200 kcal）：代谢损伤、丢肌、必反弹

- 成本：零（认知）
- 说人话：每天少于 1200 kcal（女）/1500 kcal（男），身体进入"省电 + 丢肌"模式，代谢塌方，后面怎么吃都胖，且必反弹。慢减才是真减
- 收益：避开最普遍也最伤的坑
- 证据等级：A
- 风险：高
- 来源：极低热量与代谢损伤/肌肉流失（见第 1、7 节）
- 备注：用第 2 节算出的 TDEE 当下限

2. 只做有氧不做抗阻：掉肌、基础代谢降

- 成本：零
- 说人话：光跑步跳操不举铁，脂肪和肌肉一起掉，代谢越来越低，平台来得早。把抗阻加进来，才是"减脂不减肌"
- 收益：修正最常见的运动结构错误
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：抗阻在减重保肌中的必要性（见第 5、6 节）
- 备注：每周 2–3 次就够

3. 信网红食谱不看证据：个体差异大

- 成本：零
- 说人话：某博主的"七天瘦十斤食谱"未必适合你的身体、作息和合并症。看证据分级（A/B/C）比看粉丝数靠谱
- 收益：把信任从"人"转到"证据"
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：个体对饮食干预反应的差异
- 备注：本书每条都标了证据等级，优先看 A

4. 乱买减肥药 / 微商产品：安全无保障

- 成本：钱 + 健康风险
- 说人话：朋友圈、代购的"神药"没有合规和冷链保障，GLP-1 假货尤其危险。用药只走正规医疗渠道
- 收益：保命也保钱包
- 证据等级：A
- 风险：高
- 来源：GLP-1 流通安全警示（见第 9 节）
- 备注：正规药也需医生开方

5. 忽视睡眠：<6 h 直接拉高饥饿素

- 成本：零
- 说人话：睡不够，饥饿素升、瘦素降，对高热量食物的渴望飙升，减得慢、弹得快。睡好是隐形的减重动作
- 收益：一个免费的增效项
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：睡眠与食欲激素（见第 7、8 节）
- 备注：目标 7–9 h，23 点前睡

6. 每天称体重被波动吓到：看周趋势

- 成本：零
- 说人话：一天波动 1–2 kg 全是水分和糖原，不是脂肪。天天称反而容易焦虑崩盘，看 7 天平均值才准
- 收益：稳住心态，走得远
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：体重日内波动机制（见第 1 节）
- 备注：固定时间、看趋势

7. 用"我代谢慢"自我设限：先查真实摄入

- 成本：零
- 说人话：十有八九是"记漏了"。用食物秤真实记两周，多数人会发现自己低估了 30%。先查清楚再下结论
- 收益：打破最常见的自我设限
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：自我报告低估 30%（见第 2 节第 9 条）
- 备注：秤和 App 比感觉准

8. 减太快（>1 kg/周）：掉的 mainly 是水和肌

- 成本：零
- 说人话：一周掉超过 1 kg，多半是水分和肌肉在跑路，脂肪没掉那么多，还顺带伤代谢。0.5–1 kg/周才是甜点区
- 收益：别被"速降"骗，慢才是快
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：减重速率与体成分关系（见第 1 节第 3 条）
- 备注：第一个月略快正常，之后稳下来

9. 平台期靠继续饿：越饿越丢肌

- 成本：零
- 说人话：卡住就再少吃，是最糟反应。正确做法是重算摄入（第 7 节第 4 条）、提蛋白、加抗阻，而不是加减法
- 收益：避开最坑的破局方式
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：平台期干预的常规建议（见第 7 节）
- 备注：调结构不调总量

10. 把水果 / 坚果当"零卡"敞吃：热量不低

- 成本：零
- 说人话：水果有糖、坚果油脂高，一把坚果就 100 多 kcal，半个西瓜轻松 300 kcal。它们健康，但绝不零卡，敞吃一样胖
- 收益：堵上最易忽视的超标口
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：水果/坚果的能量密度常识
- 备注：定量吃，别拿碗

11. 减重期完全戒酒 / 戒社交：不可持续

- 成本：零
- 说人话：为了减把生活过成苦行，多半撑不过俩月。酒精本身热量高（尤其甜酒），但"滴酒不沾 + 不社交"会让你更早放弃。学会在低卡范围里留余地
- 收益：把减重变成能长期活下去的事
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：可持续性与社交支持（见第 8 节）
- 备注：偶尔小酌比彻底崩盘强

12. 把"瘦"当终点而非习惯：最容易反弹

- 成本：零
- 说人话：减到目标就"解放"、回老样子，是反弹的最大根源。真正赢，是承认这辈子都要聪明吃、规律动。"瘦"是习惯的副产品，不是终点
- 收益：一句点透"怎么不反弹"
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：长期体重管理核心结论（见第 8 节第 12 条）
- 备注：把健康吃法当你的新常态